PROTOCOLLO 25

Mobilizzazione in distrazione caudale dell'ATM

Tecnica intraorale per ridurre il dolore articolare e migliorare l'apertura

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Dolore articolare con ridotta apertura
- ✓ Ipomobilità dopo immobilizzazione
- ✓ Spostamento discale senza riduzione in fase non acuta

Controindicazioni e precauzioni

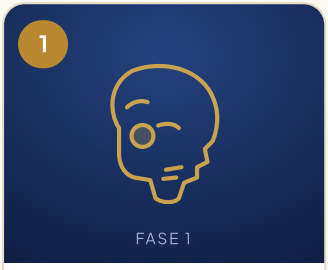
- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: dal lato opposto all'articolazione da trattare, guanto monouso, pollice sui molari inferiori omolaterali, dita esterne sul corpo della mandibola; l'altra mano stabilizza il cranio sulla regione temporale.

Esecuzione passo dopo passo



Presa

Pollice sui molari inferiori, stabilizza il cranio con l'altra mano.



Distrazione

Trazione caudale lenta e progressiva, perpendicolare al piano occlusale.



Oscillazioni

Mantieni la distrazione con oscillazioni di grado I o II per il dolore.



Progressione

Se tollerato passa al grado III e aggiungi lo scivolamento anteriore.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	I e II (Maitland) se prevale il dolore
Grado	III mantenuto se prevale la rigidità
Tempo	3 serie da 30 a 60 secondi, pausa 30 secondi

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA	DOLORE (NRS 0 A 10)	TRAIETTORIA
____ mm	**____ / 10**	**Retta / Deviata**
senza dolore e massima, con calibro	a riposo e in funzione	osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ La forza si dosa sulla risposta, mai sul dolore
- ✓ Il pollice resta sui molari, non sugli incisivi
- ✓ Associa esercizio attivo a fine seduta

Errori da evitare

- ! Trazione brusca o anteriore all'inizio
- ! Lavorare con i masticatori in tensione
- ! Proseguire con dolore acuto o click doloroso

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Autodistrazione	Pollice sui molari, leggera trazione verso il basso mantenuta	3 x 30 secondi, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Se dopo 3 o 4 sedute l'apertura non migliora di almeno 5 mm, rivaluta il quadro secondo DC/TMD.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.